

Mindful *eating*

Uważne jedzenie — protokół MB-EAT Kristeller (8–10 tyg.). *Uważność + jedzenie + regulacja emocji*. RCT: redukcja epizodów o 70% w BED. Adaptacja dla BN — wolniejsze tempo.

CZAS: 30 min · trening codzienny · Etap 2–3 CBT-E · uzupełnienie ekspozycji

ŹRÓDŁO: Kristeller & Wolever (2011); Kristeller i in. (2014, RCT BED)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **jedzenie automatyczne vs uważne** (sekcja 1), **sześć elementów MB-EAT** (sekcja 2). Sekcja 3 — praktyki. Sekcja 4 — refleksja.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mindful eating — *uważne jedzenie*; praktyka oparta na uważności Kabat-Zinna, zaadaptowana do zaburzeń odżywiania jako **MB-EAT** (*Mindfulness-Based Eating Awareness Training*, Kristeller & Wolever 2011). Założenie: większość jedzenia w bulimii jest **automatyczne** — bez świadomości smaku, sytości. Epizody są *ekstremalną* formą jedzenia bezświadomego. Kristeller i in. (2014) **RCT** dla BED: redukcja epizodów o **70%** w 12 tyg. Adaptacja dla bulimii: wolniejsze tempo, kombinacja z CBT-E. Wymaga stabilności 3+2. Szczególnie wartościowy u pacjentów z *aleksytymią*.

01 ● Jedzenie automatyczne vs uważne

JEDZENIE AUTOMATYCZNE

- Bez świadomości smaku
- Z ekranem (telefon, TV, laptop)
- Szybkie, bez przerw
- Brak rejestracji sytości
- Brak przyjemności po posiłku
- Ekstremalna forma: epizod

JEDZENIE UWAŻNE

- Świadomość smaku, tekstury, zapachu
- Bez ekranów
- Wolne tempo, z przerwami
- Rejestracja sytości w trakcie
- Przyjemność i satysfakcja
- Świadomość emocji wokół jedzenia

Klucz: mindful eating *nie* jest „perfekcyjnym” jedzeniem — jest *świadomym* jedzeniem. Możesz uważnie zjeść hamburgera albo uważnie sałatkę. Treść posiłku nie jest istotna — istotny jest *sposób*.

02 = Sześć elementów MB-EAT

1 · UWAŻNOŚĆ JEDZENIA

Świadomość *smaku, faktury, zapachu*, temperatury. Kilka pierwszych kęsów uważnie. Reszta — w miarę możliwości.

2 · ŚWIADOMOŚĆ GŁODU I SYTOŚCI

Skala 0–10 (z B4). Przed, w trakcie, po posiłku. Trening interoceptywny.

3 · UWAŻNOŚĆ EMOCJI

Jakie emocje pojawiają się *wokół* jedzenia? Wstyd, lęk, przyjemność, satysfakcja, smutek. Zauważanie bez oceny.

4 · AKCEPTACJA

Akceptacja tego, co się pojawia — bez walki, bez prób kontroli. Stan obserwatora.

5 · WSPÓŁCZUCIE WOBEC SIEBIE

Trening *self-compassion* — łagodny ton wewnętrzny, jak do bliskiego przyjaciela. Bez samokrytyki za niedoskonałości.

6 · 8–10 TYGODNI GRUPOWO

Standardowy format MB-EAT — sesje grupowe co tydzień + praktyka codzienna. Praca własna na podstawie podręcznika też skuteczna.

PRAKTYKA Z RODZYNKĄ

Klasyka MB-EAT. 1 rodzynka przez 10 minut: oglądasz, wąchasz, dotykasz, próbujesz, żujesz wolno, połykasz świadomie. Trening podstawowy.

3 ŚWIADOME KĘSY

Codziennie zacznij jeden posiłek od **3 świadomych kęsów**. Bez ekranu. Reszta jak zwykle.

PAUZA W ŚRODKU POSIŁKU

Po połowie posiłku — krótka pauza (30 sekund). Oddech. Sprawdzenie skali sytości 0–10. Decyzja: kontynuować czy kończyć?

SKANOWANIE EMOCJI

Przed posiłkiem 30 sekund: jakie emocje są obecne? Jaki głód? Czego potrzebuje moje ciało, czego potrzebuje umysł?

CO ZAUWAŻYŁEM/-AM W CIĄGU TYGODNIA

— co działało, co nie, jak smakowało jedzenie, jakie emocje

Klucz: mindful eating jest *treningiem świadomości*, nie kolejną „dieta”. Kristeller & Wolever (2011) opracowali MB-EAT na podstawie *Mindfulness-Based Stress Reduction* Kabat-Zinna (1990) i dziesięcioletnich badań klinicznych. W **RCT 2014** dla BED: redukcja epizodów o **70%** w 12 tygodniach, z trwałością po 6 miesiącach. Dla BED efekty są *silniejsze* niż dla bulimii — w bulimii kompensacje wymagają specyficznej pracy CBT-E, której MB-EAT nie zastępuje. *Uzupełnienie* jest jednak wartościowe: pacjenci z **aleksytymią** (trudność z rozpoznawaniem emocji), *wysoką dezintegracją jedzeniową* (jedzenie automatyczne, bez świadomości), *komorbidnością* z lękiem szczególnie korzystają. **Pierwsze 2-3 tygodnie** praktyki są często trudne — pacjenci zgłaszają „*nie umiem być uważny przy jedzeniu*” lub „*świadomość smaku wywołuje lęk*”. To *normalne*. Praktyka wymaga 6-8 tygodni regularnego treningu, by stała się dostępniejsza. *Nie* jest dla wszystkich — pacjenci z ciężką traumą żywieniową lub w ostrej fazie BN mogą doświadczyć retraumatyzacji. **Decyzję** o wprowadzeniu MB-EAT podejmuj z terapeutą.